

Лучшие практики в рамках реализации проекта «Запись на прием к врачу»



Тема доклада:

«Организация отделения оказания медицинской помощи на дому»

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5»

Докладчик: Главный врач Горшкова Александра Сергеевна

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника №5»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО

КАРТОГРАММА ТВСП, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

▪ Численность населения на 01.07.2023

20323 ребенка.

Из них детей до года 758 человек.

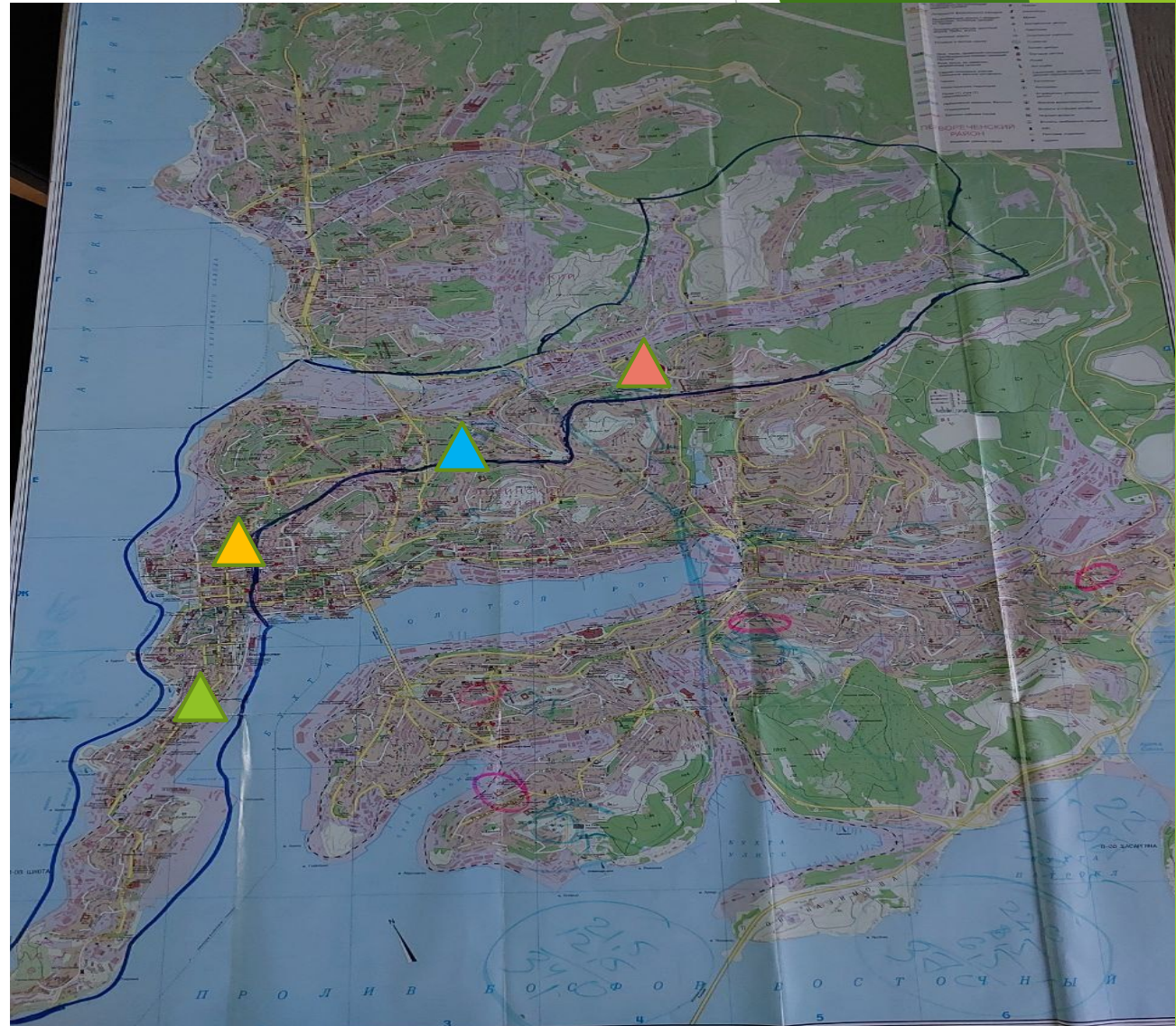
С 1-4 лет 3703 человека.

С 5-до 18 лет 15862 человека

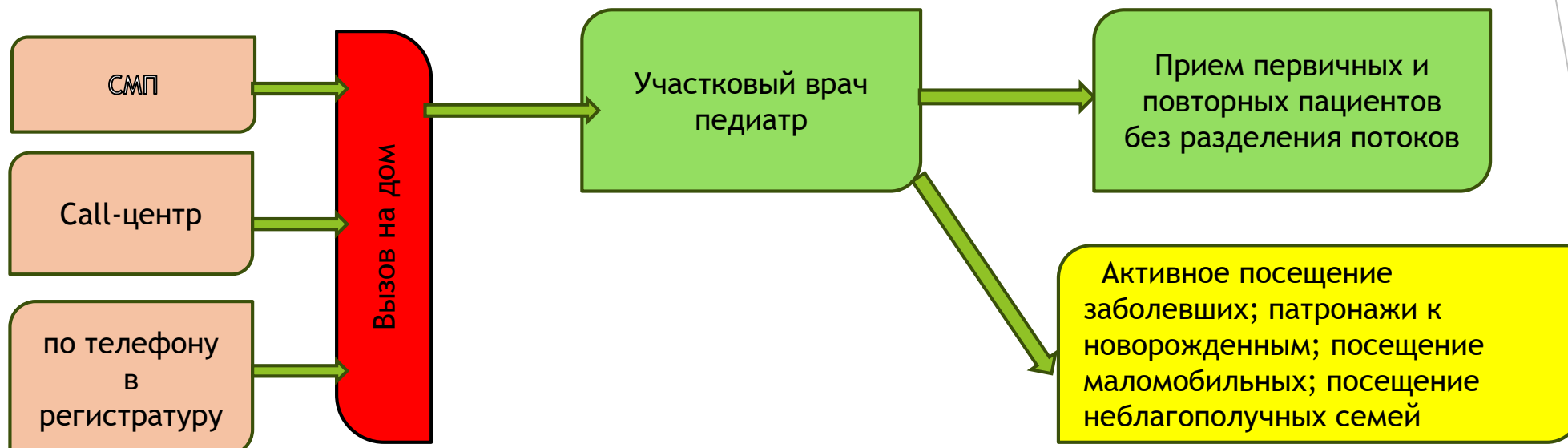
▪ Работает 4 территориально выделенных структурных подразделения по 6 педиатрических участков:

- 1. Бестужева 13
- 2. Уткинская 10
- 3. Красного знамени 71 А
- 4. Сельская 9.

Общая протяженность территории обслуживания по прямой порядка 15 км. ТВСП располагаются относительно равноудаленно друг от друга. Транспортная доступность удовлетворительная, но между 3 и 4 ТВСП на общественном транспорте нужно ехать с пересадками и достаточно далеко идти от остановки общественного транспорта



Клиентский путь (было до 2016 года):



Предпосылки для создания отделения оказания медицинской помощи на дому



Кабинет дежурного врача был создан на базе КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5» еще в конце 2017 года.

Были реализованы организационно-планировочные решения по разделению потоков пациентов. Был восстановлен дополнительный вход в поликлинику для детей с признаками острых респираторных заболеваний. В штатное расписание введена должность врача педиатра кабинета дежурного врача 2 ставки для работы в 2 смены.

В расписании участковых врачей педиатров выделялись отдельные слоты для записи детей на повторные осмотры «от дежурного врача». Обычно до 5 слотов.

Прием участковых врачей был увеличен с 3-х часов до 4 часов.

Параллельно был выделен поток пациентов для проведения плановой вакцинации по национальному календарю, что также позволило даже в период подъема заболеваемости без ущерба качеству оказания медицинской помощи увеличивать слоты как для первичного, так и для повторного приема.

Клиентский путь 2019 год



Но оставался открытым вопрос о передачи обслуживания вызовов на отдельное структурное подразделение с целью сократить время ожидания врача на дому, увеличить количество слотов у участковых врачей и тем самым повысить доступность ПМСП для населения, а также снизить риски профессионального выгорания.

В целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению и повышения ее доступности, в соответствии статей 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012г. 366-н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Кабинет дежурного врача по адресу ул. Бестужева 13 на первом этаже кабинет 112, с отдельным входом.
2. Работу Кабинета организовать с привлечением врача педиатра, в период повышенного подъема заболеваемости предусмотреть дополнительно прием врача инфекциониста
3. Непосредственное руководство работой Кабинета возложить на заведующую педиатрическим отделением - Горлову О.А.
4. Утвердить положение о работе Кабинета дежурного врача (Приложение № 1).
5. Информировать прикрепленное население о правилах оказания медицинской помощи детям в Кабинете дежурного врача КГБУЗ «ВДП № 5», путем размещения информации на стенде у регистратуры и на Интернет-сайте поликлиники.
6. Назначить ответственным главную медицинскую сестру Тригуб Д.А. за оснащение Кабинета дежурного врача согласно Приложению № 2.
7. Утвердить перечень укладки для оказания неотложной медицинской помощи детям:
 - 7.1. В кабинете дежурного врача (Приложение №3);
 - 7.2. На дому (для участкового педиатра) (Приложение №4).
8. Главной медицинской сестре Тригуб Д.А. укомплектовать укладки в соответствии с приказом.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.С. Горшкова

Цель проекта:

Увеличение количества слотов на плановом приёме участкового врача педиатра, в том числе в период резкого подъема заболеваемости ОРВИ



Пути решения:

1. Создание отделения оказания медицинской помощи на дому
2. Передача функций по обслуживанию детей на дому с участкового врача педиатра на врача педиатра вновь созданного отделения
3. Увеличение времени приёма участкового врача педиатра в поликлинике до 5 и 5,5 часов.
4. За участковым врачом педиатром оставить: патронажи к новорожденным детям; работу на дому с маломобильными пациентами; активное посещение неблагополучных семей на участке; активы к больным (при необходимости)

Проблемы:

Отсутствие доступа к МИС «БАРС» на дому

Отсутствие выделенного транспорта для обеспечения работы врача педиатра отделения

Отсутствие отдельных слотов для выдачи талона с указанием даты и времени повторного приёма в поликлинике врачом педиатром отделения

Отсутствие врача педиатра, который бы согласился работать только на вызовах

Отсутствие алгоритма взаимодействия между врачом педиатром отделения и участковым врачом педиатром

Пути решения:

Приобретение ноутбука с установкой доступа в МИС «БАРС»

Выделение отдельной машины для отделения

Выделение слотов в ежедневном расписании участкового врача педиатра. Количество слотов зависит от подъема заболеваемости

Привлечение кадров

Разработать алгоритм взаимодействия с целью соблюдения преемственности, обновление приказа



Клиентский путь (стало):



ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ на 1 участкового педиатра

Специальность	Общее количество в день было/стало	Количество конкурентных абсол	Количество часов на приеме	Количество свободных слотов на доступный горизонт записи (14 дней)
врач-педиатр участковый	17/25	12/18-21	4/ 5-5,5	0/29

За время открытия отделения с 01.02.2023 года обслужено на дому

Бестужева 13	809	
Красное знамя 71 а	838	

Реализация данных мероприятий позволила:

1. Увеличить время приема участковыми педиатрами с 3-х до 5-5,5 часов. А при необходимости до 6 часов.
2. Снижение времени ожидания врача при вызове в 2,5 -3 раза.
3. Снижение времени ожидания приема в кабинете дежурного врача практически в 2 раза.
4. Возможность безболезненного перераспределения нагрузки между службами в период подъема заболеваемости, в т.ч. прием вызовов от СМП.
5. Работа участкового врача стала более плановой, что благоприятно влияет на психологический настрой участковой службы, а так же является профилактикой профессионального выгорания.
6. Значительное снижение жалоб на длительное ожидания врача на дому

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ

перспективы

- ▶ Тиражировать на другие структурные подразделения
- ▶ Организация забора анализов на дому
- ▶ Проведение отоскопии на дому
- ▶ Экспресс тесты на бактериальную инфекцию (В-гемолитический стрептококк)
- ▶ При укомплектованности отделения средним медицинским персоналом возложить на них обязанности по активному посещению на дому с целью динамического наблюдения за заболевшими детьми, взятия анализов.

**Нет ничего
невозможного, главное
захотеть и поверить в
свои силы.**

